جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : فاطمه احمد غبوش محمد
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** الحسين **العنوان :** نصار
رقم البطاقة : 28905102100881 **رقم التليفون :** 01012735017 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 10-05-1989**المهنة :** بدون عمل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(--------------------------) **التوقيع:(--------------------------)**

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام اشعه مقطعيه علي البطن والصدر والحوض بالصبغه [11127] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : --------------------------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** -------------------------- **التوقيع:** د/ كيلاني
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** -------------------------- **التوقيع:** ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** -------------------------- **التوقيع:** نرمين رمضان

جوستاف روسي

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ----------------------- **ا.د/** ----------------------- **د/** ----------------------- **د/** -----------------------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : --
خطة العلاج : --
المستشفي : -- **قسم :** --
جهة العلاج : -- **نفقات :** --
ملاحظات : --

رئيس **المجلس الطبي المتخصص**	**مدير عام** **مديرية الشئون الصحية**	**ختم** **شعار الجمهورية**

Name: فاطمه احمد غبوش محمد
National ID: 28905102100881

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

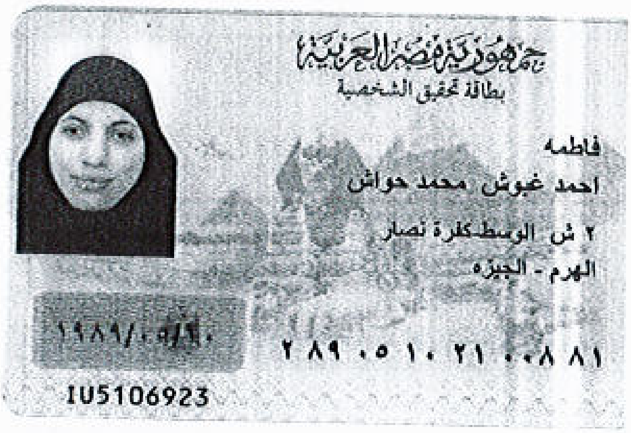
نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : yyyy-mm-dd --:-- --	**تاريخ وساعة الخروج :** 05-07-2026 01:17 PM

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Contrast-enhanced CT Chest & abdomen and pelvis

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



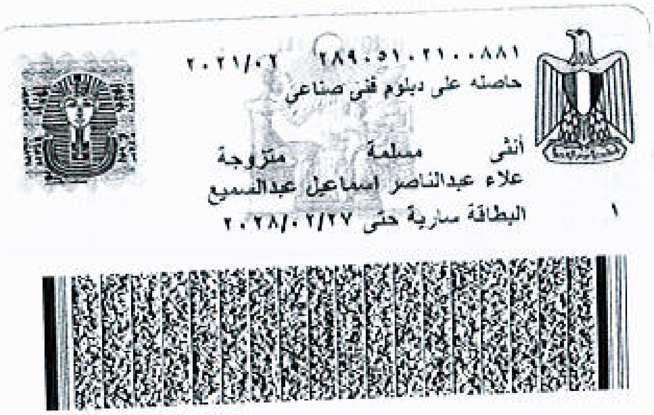
جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

فاطمه
احمد غبوش محمد حواش
٢ ش الوسط كلرة نصار
الهرم - الجيزه

١٩٨٩/٠٥/١٠

٢٨٩٠٥١٠٢١٠٠٨٨١

IU5106923



٢٨٩٠٥١٠٢١٠٠٨٨١ ٢٠٢١/٠٢
حاصله على دبلوم فني صناعي
أنثى مسلمة متزوجة
علاء عبدالناصر اسماعيل عبدالسميع
١ البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/٠٢/٢٧

DMS

← اشعه عاديه على الصدر

← موجات صوتيه على البطن والحوض

National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Patient Name	: [illegible]	Request No.	: 13007341
Patient No.	: 28905102100881	Request Date	: 30/07/2024
Path No.	: SR-1043/24	Verification Date	: 05/08/2024
Sex	: Female	Financial Category	: أورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 35 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical data:
Right breast mass.

Nature of specimen:
Block and slide revision.

Gross examination
One block labelled by (3957/24) and three slides were received.

Microscopic examination:
* Histological type: Invasive duct carcinoma micropapillary pattern.
* Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+mitosis): (3+2+1) Grade II .
* DCIS:Could not be detected within the limits of biopsy recieved.
*Angioinvasion; Could not be detected within the limits of biopsy recieved.
*IPT:
- ER No nuclear reaction in tumor cells (score 0/8).
- PR: Moderate nuclear reaction in 30% of tumor cells (score 5/8).
- Her2: Strong complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 3+).

Diagnosis:
Right breast mass, block and slide revision:
Invasive duct carcinoma, Grade II with micropapillary pattern.
IPT:
- ER: Negative (score 0/8).
- PR: Positive (score 5/8).
- Her2: Positive (score 3+).

Prof.Amal Hareedy

Verified by :
dr.esraa magdy

Name: فاطمه احمد غيوش محمد
MR. : 2775

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من
بشأن تقرير طبي للمريض

بقسم:
رقم طبي:

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :
تاريخ وساعة الخروج :

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient was diagnosed with right breast cancer, clinical stage T4D N1 M0. Neoadjuvant chemotherapy with the TCHP regimen was administered, followed by radiotherapy to the right mammary region on 26/01/2025. The pathology was reported as YPT3N3 (17/18) with adjustment to TDM-1. A port was placed, and the patient was started on tamoxifen for five years in combination with Zoladex beginning in 2025; today the patient received Zoladex, tamoxifen, and supportive care.

After discussion with Dr. Shaimaa regarding revision of estrogen and progesterone receptor status pre-operatively versus post-operatively, the patient was advised to continue tamoxifen. An assessment was performed with a chest X-ray and pelvic ultrasound (AST: 52).

The treatment plan was updated to continue tamoxifen alone, noting that the estrogen receptor expression was 2% with weak nuclear reaction. Zoladex was discontinued, and the patient was instructed to return for a pharmacy examination in three months; at that time the breast was locally free but there was tenderness in the left upper pelvis.

Tamoxifen monotherapy was continued, with Zoladex stopped three months prior. On examination the breast remained locally free, though tenderness persisted in the left upper pelvis. MRI of the hip joints performed on 08/08/2026 showed mild left hip arthritic changes and minimal bilateral hip joint abnormalities. The patient will undergo annual follow-up with sonographic mammography and laboratory assessment of estradiol, FSH, and LH, as she stopped Zoladex seven months ago and has not had menses.

تحريرا في ,

التاريخ : 21-09-2026
الوقت :

الطبيب المعالج : نرمين مصطفي عبد القادر بهي الدين

يعتمد ,

PATIENT NAME: FATMA AHMED Ghabosh MOHAMMED
GENDER: Female
DATE : 03-Aug-2024 12:49 PM

PATIENT ID: 10124244795
AGE: 35 y
ORDER: 2966667,2966668

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS WITH TRIPHASIC LIVER STUDY

FINDINGS:

1-CHEST

- Right breast UOQ ill defined enhancing mass lesion measuring about 26x64 mm in axial diameters.
- Associated multiple enlarged ipsilateral level I, II and III axillary lymph nodes; the largest is seen at level I measuring about 17x18 mm in axial diameters.
- No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No CT evidence of pathologically enlarged hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers.
- No pericardial effusion detected.

2- ABDOMEN AND PELVIS

- Enlarged liver showing diffuse fatty infiltration. No focal lesions or intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
- Normal appearance of the pancreas, spleen, kidneys, adrenals, aorta, and I.V.C.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.

PATIENT NAME: FATMA AHMED Ghabosh MOHAMMED
GENDER: Female
DATE : 30-Jul-2024 02:58 PM

PATIENT ID: 10124244795
AGE: 35 y
ORDER: Z102856,Z102857

FULL FIELD DIGITAL MAMMOGRAPHY AND COMPLEMENTARY ULTRASOUND

INDICATION:

- Right breast pathologically proven Invasive micropapillary carcinoma, grade 3

TECHNIQUE:

- CC and MLO view.
- Additional DBT.
- Complementary ultrasound

REPORT:

- Heterogenous dense parenchyma , may obscure small lesions (ACR C).

Right breast:

- Right UOQ &LOQ global asymetry associated with central skin thickening.
- **By Complementary Ultrasound :**
- Right large ill defined heterogenous predominant hypoechioc altered parenchyma mounting to mass formation extended from 8 o;clock to 12 o;clock measuring 7.8 x 3.4 cm with suspected intraductal extension , away from the nipple by about 2 cm & deep from the skin by about 5.5 mm
- Multiple pathologically (more than 3 in number) level 1 & 2 (retro pectoral) axillary lymphadenopathy.
- Free right supra calvicular region.

Left breast:

- No spiculated mass lesions or grouped microcalcifications.
- **Complementary Ultrasound :**
- Heterogenous echogenic parencyma of motelled appearnce with scattered cysts few of them are complicated
- No solid mass lesions.
- Normal skin thickness and contour.
- Normal nipple areola complexes.
- Nonspecific axillary lymph nodes.

OPINION:

- Right breast pathologically proven malignant mass associated with multiple pathological enlarged axillary lymphadenopathy (BIRADS6).
- Left breast adenosis with cystic changes few of them are complicated (BIRADS 2)

RECOMMENDATION:

Referral to clinic

Patient Name : [illegible]
Patient No. : 28905102100881
Req. Id : SR-1043/24
Sex : Female
Age : 35 Y
Referring Doc :

Request No. : 13007341
Request Date : 30/07/2024
Verification Date : 05/08/2024
Financial Category : [illegible]
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical data:
Breast mass.

Type of specimen:
Block and slide revision.

Gross examination:
One block (labelled by (3357/24) and three slides were received.

Microscopic examination:
Histological type: Invasive duct carcinoma micropapillary pattern.
Scores (differentiation +nuclear pleomorphism+mitosis): (3+2+1) Grade II .
DCIS Could not be detected within the limits of biopsy recieved.
LV invasion: Could not be detected within the limits of biopsy recieved.

ER: No nuclear reaction in tumor cells (score 0/8).
PR: Moderate nuclear reaction in 30% of tumor cells (score 5/8).
Her2: Strong complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 3+).

Diagnosis:
Breast mass, block and slide revision:
Invasive duct carcinoma, Grade II with micropapillary pattern.

- ER: Negative (score 0/8).
- PR: Positive (score 5/8).
- Her2: Positive (score 3+).

Dr. Amal Harassy

Verified by :
dr.esraa magdy

BAHEYA
Radiology Department

بهية
قسم الأشعة التشخيصية

PATIENT NAME: FATMA AHMED Ghabosh MOHAMMED
GENDER: Female
DATE : 12-Aug-2024 01:38 PM

PATIENT ID: 10124244795
AGE: 35 y
ORDER: 2985198

99MTC-MDP BONE SCAN

Desired Information: -

35-year-old female with known breast cancer, for skeletal survey as part of IS metastatic work-up.

Technique:

Delayed Whole body imaging in anterior and posterior projection performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi 99m Tc-MDP in the following manner:

Findings:

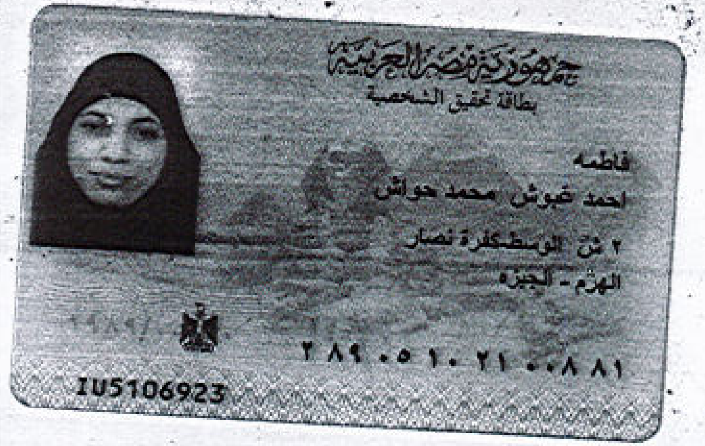
- No hot/cold focal areas of abnormal tracer accumulation that would account for osseous deposits could be detected allover the surveyed skeleton.
- Both kidneys are normally visualized.

Conclusion:

No scintigraphic evidence of metastatic bone lesions all-over the surveyed skeleton.

Reported By,

Dr. ElShaymaa Hussein, Nuclear Medicine Consultant 13-Aug-2024 02:23 PM

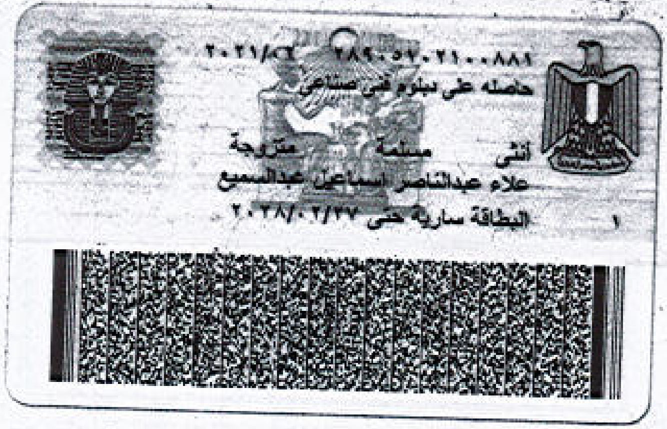


جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

فاطمه
احمد عويش محمد حواش
٢ ش الوسطى كفرة نصار
الهرم - الجيزه

٢٨٩٠٥١٠٢١٠٠٨٨١

IU5106923



٢٠٢١/٤ ٢٨٩٠٥١٠٢١٠٠٨٨١
حاصله على دبلوم فنى صناعى
أنثى مسلمة متزوجة
علاء عبدالناصر اسماعيل عبدالسميع
١ البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/٠٢/٢٧

هرمون تاموكسيفين

National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]